Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

VESÍCULA E VIAS BILIARES

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Meu querido aluno Estrategista,

Este é o RESUMO ESTRATÉGICO. O objetivo dele é focar nos principais temas que foram cobrados nos concursos de Residência sobre vesícula e vias biliares.

Com este resumo, você será capaz de responder em torno de 80% das questões que caírem sobre o tema; dos 20% faltantes, garanto que 10% são questões que a banca cobra tão pouco que se aparecerem é quase um evento e os outros 10% são devaneios e rodapés de artigos e livros. Para os últimos 20%, é necessário dar uma lida no livro-digital, lá temos o material completo e detalhado.

E como eu posso afirmar isso? Depois de responder, item a item, mais de 300 questões sobre o tema, ficamos fera no assunto e capaz de observar o que é cobrado regularmente e o que é raro.

Então, chega de delongas, que o "tempo ruge e a Sapucaí é grande".

Estratégia MED

@proftomascoelho

@estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

/estrategiamed

Estratégia MED

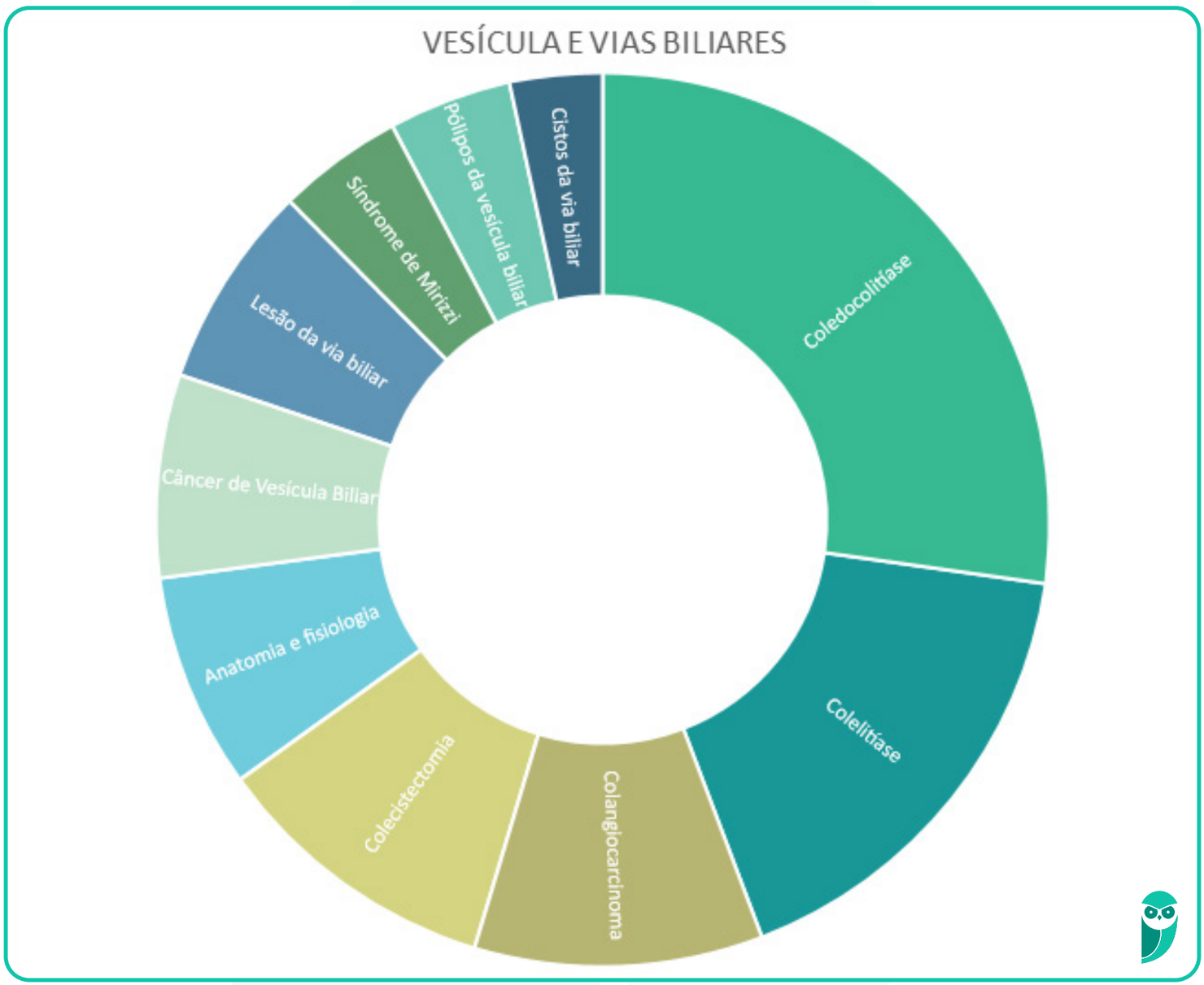
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 CONCEITOS IMPORTANTES 5
2.0 COLELITÍASE 6
2.1 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO 8
2.2 COMO É UMA CÓLICA BILIAR TÍPICA? 9
2.3 COMO FAÇO O DIAGNÓSTICO DE COLELITÍASE? 10
2.3.1 ULTRASSONOGRAFIA TRANSABDOMINAL 11
2.4 COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA 11
3.0 COLEDOCOLITÍASE 13
3.1 QUANDO SUSPEITAR? 13
3.2 O QUE FAZER APÓS A ULTRASSONOGRAFIA? 14
3.3 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 16
4.0 TRATAMENTO CIRÚRGICO 18
4.1 QUANDO DEVO INDICAR UMA DERIVAÇÃO BILIODIGESTIVA? 18
5.0 LESÃO DA VIA BILIAR 20
5.1 COMO INVESTIGO UMA LESÃO DA VIA BILIAR? 21
6.0 PÓLIPOS DE VESÍCULA BILIAR 23
7.0 CÂNCER DE VESÍCULA 25
8.0 COLANGIOCARCINOMA 27
9.0 LISTA DE QUESTÕES 30
10.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 31
11.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 32

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Seja bem-vindo ao RESUMO DE VESÍCULA E VIAS BILIARES!



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

1.0 CONCEITOS IMPORTANTES

Começaremos a falar das patologias da vesícula e das vias biliares, e o principal tema cobrado é quanto aos cálculos da vesícula e da via biliar. Se somarmos colelitíase, coledocolitíase e o tratamento cirúrgico dessas patologias, temos aproximadamente 55% do total das questões!

Por isso, querido aluno, iniciaremos definindo o que é colelitíase, o que é coledocolitíase e suas principais diferenças.

COLELITÍASE: é a formação de cálculo (ou pedra) no **interior da vesícula biliar**.

COLEDOCOLITÍASE: é a presença de cálculo **no interior do colédoco.**

Para uma melhor didática, separamos a colecistite e a colangite. Elas fazem parte do material de ABDOME AGUDO INFLAMATÓRIO por conta das suas particularidades. Lembraremos aqui o que cada um dos termos significa:

COLECISTITE: é a inflamação da parede da vesícula e ocorre, mais comumente, pela obstrução ao fluxo da bile por um cálculo no ducto cístico.

COLANGITE: é a infecção da via biliar causada pela obstrução ao fluxo da bile. Por isso, é uma complicação que pode ocorrer em decorrência da coledocolitíase.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
2.0 COLELITÍASE

A colelitíase corresponde a 17% do total das questões. Quais são os principais temas cobrados?

- Formação dos cálculos biliares, explorando a fisiopatologia;
- Indicações de colecistectomia nos casos de cálculo assintomático;
- Identificar, pelos dados clínicos, uma cólica biliar típica;
- Escolher o exame de imagem mais apropriado para investigação e diagnóstico.

Esses serão os temas que exploraremos no nosso resumo estratégico! Hora de começar!

COLELITÍASE: É O CÁLCULO NO INTERIOR DA VESÍCULA BILIAR.

Iniciaremos falando dos cálculos e explorando as principais características de cada um deles.

Os principais tipos de cálculos são os cálculos de colesterol, cálculos pigmentares pretos e cálculos pigmentares marrons.

O cálculo de colesterol é o principal cálculo da vesícula biliar. Ele ocorre por conta da supersaturação do colesterol na bile (falaremos mais à frente como e por que isso ocorre).

Diferentemente do que você pode achar, o cálculo puro de colesterol não é o principal cálculo da vesícula biliar. Ele corresponde a menos de 10% dos cálculos da vesícula biliar.

Se não é o cálculo puro, qual é o cálculo mais comum da vesícula biliar? O cálculo misto, formado por colesterol e cálcio. **Ele corresponde a 70% de todos os cálculos da vesícula biliar.**



Cálculo Colesterol

- ✓ Principal constituinte dos cálculos biliares
- ✓ Supersaturação de colesterol na bile
- ✓ Cálculos de colesterol e cálcio = 70%
- ✓ Cálculos puros de colesterol = < 10%

Os cálculos pigmentares pretos são formados, principalmente, por **bilirrubinato de cálcio**. Eles podem ser formados de duas formas:

- Secundários às doenças hemolíticas. Isso ocorre porque há um aumento na bilirrubina não conjugada, presente nas hemácias. Na vesícula, sua concentração aumentada favorece à formação de cálculos, porque é menos solúvel em água.
- Pacientes cirróticos: o mecanismo de formação dos cálculos no paciente cirrótico é multifatorial, estando relacionado à excreção piorada da bilirrubina não-conjugada, dismotilidade da vesícula biliar e aumento da concentração de estrogênio, que é fator de risco para a formação dos cálculos.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Cálculo Preto ⇨

- ✓ Associado a **DOENÇAS HEMOLÍTICAS**
- ✓ **CIRROSE HEPÁTICA**
- ✓ Bilirrubina não conjugada é o principal fator para formação do cálculo.
- ✓ Principal constituinte: Bilirrubinato de cálcio

Os cálculos pigmentados marrons estão relacionados à dismotilidade biliar e à infecção bacteriana, sendo que o principal microrganismo é a *Escherichia coli.* Qual é a relação entre eles? Restos bacterianos, junto a bilirrubina não conjugada e cálcio, formam o cálculo marrom. Aqui, como no cálculo preto, o principal constituinte é o bilirrubinato de cálcio.

Os cálculos marrons são os **cálculos primários de colédoco**.



Cálculo Marrom ⇨

- ✓ Associado a dismotilidade biliar
- ✓ Cálculos primários de colédoco
- ✓ Bactérias - *Escherichia coli*
- ✓ Bilirrubina não conjugada
- ✓ + cálcio e restos bacterianos
- ✓ Principal constituinte: Bilirrubinato de cálcio

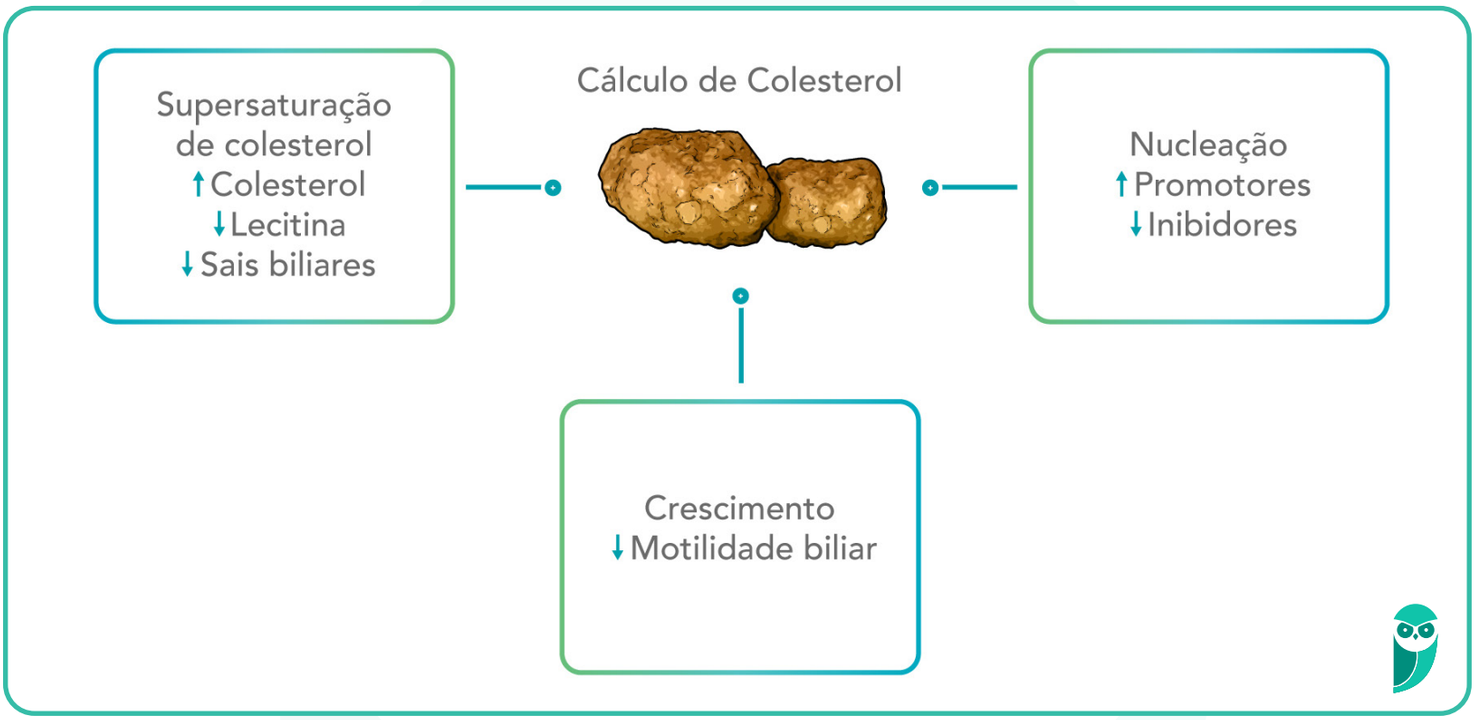
A formação dos cálculos de colesterol é frequentemente cobrada nos concursos!

Três eventos são considerados fundamentais para a formação do cálculo de colesterol. São eles:

- **Supersaturação de colesterol:** o colesterol é pouco solúvel na bile. Para "melhorar" a solubilidade, ele forma micelas com a lecitina e os sais biliares. Logo, devemos ter um equilíbrio entre esses três constituintes da bile. Quando há o aumento na concentração da bile, tanto a lecitina quanto os sais biliares diminuem sua concentração, desfazendo as micelas e favorecendo a precipitação do colesterol.
- **Nucleação:** com a precipitação do colesterol, há um aumento nos fatores que promovem a nucleação dele, formando cristais de colesterol, que darão origem ao cálculo.
- **Crescimento:** quando há uma alteração na motilidade da bile, em que ela fique mais tempo concentrada na vesícula biliar, isso favorece o crescimento do cálculo.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Dê uma olhada na figura abaixo, que resume bem a fisiopatologia da formação do cálculo de colesterol.



2.1 EPIDEMIOLOGIA E FATORES DE RISCO

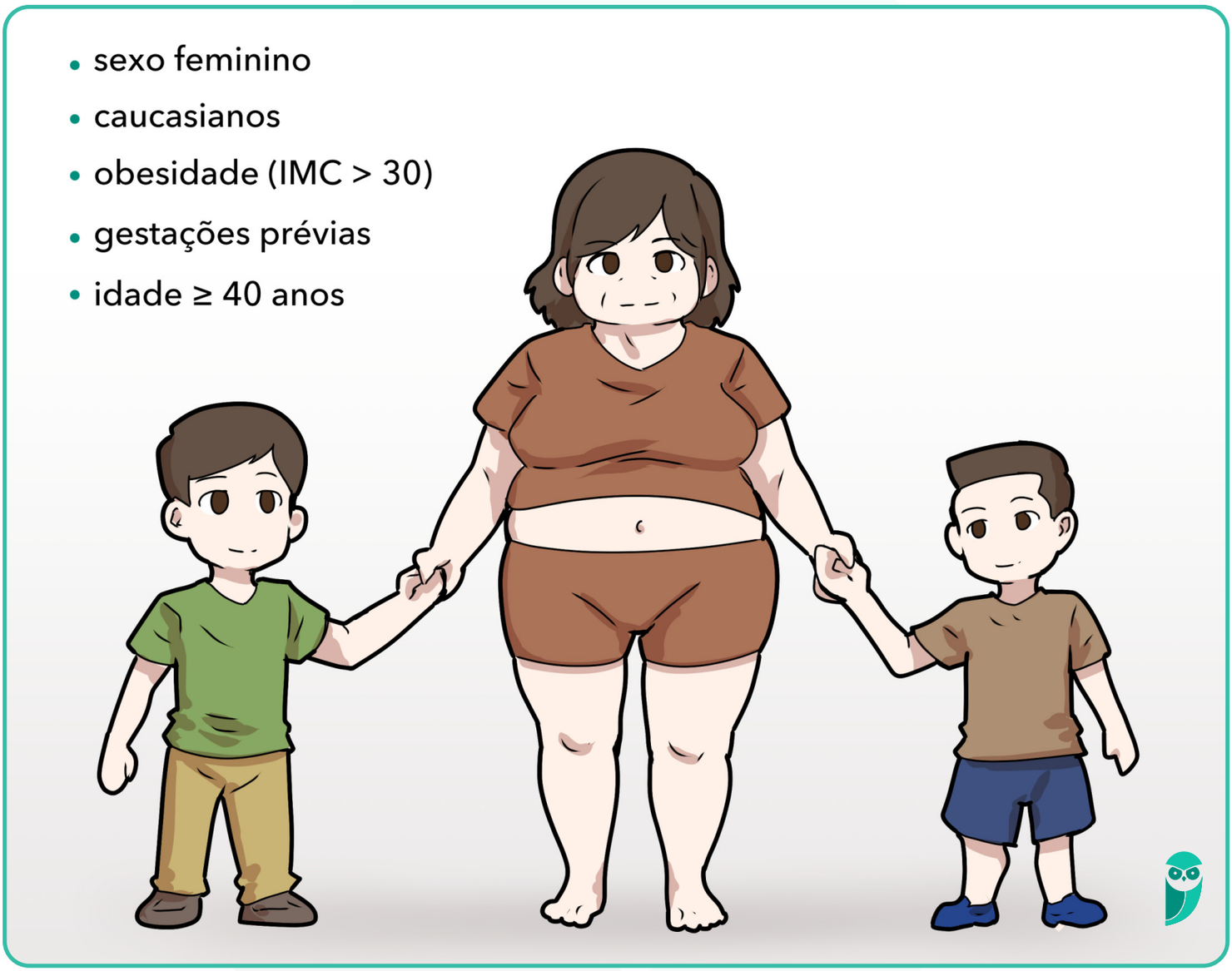
A prevalência da colelitíase na população mundial é em torno de 10-20%, sendo que 80-85% dos casos são **ASSINTOMÁTICOS.**

Os cinco principais fatores de risco para colelitíase são conhecidos, em inglês, como "5 F's". São eles:

- ✓ Sexo **FEMININO** (FEMALE)
- ✓ População **CAUCASIANA** (FAIR - claro)
- ✓ **Obesidade** (FATTY - gordo)
- ✓ **Gestações prévias** (FERTILE - fértil)
- ✓ **Idade ≥ 40 anos** (FORTY - quarenta)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Olhe esta figura para você nunca mais se esquecer dos principais fatores de risco:



2.2 COMO É UMA CÓLICA BILIAR TÍPICA?

A cólica biliar é causada pela obstrução ao fluxo da bile pelo ducto cístico por cálculo ou lama biliar. Suas principais características são uma dor em hipocôndrio direito, que se inicia após uma alimentação copiosa ou rica em gordura, podendo estar ou não associada a náuseas e/ou vômitos, que não costuma durar mais que 6 horas. Olhe esta imagem resumindo as características:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

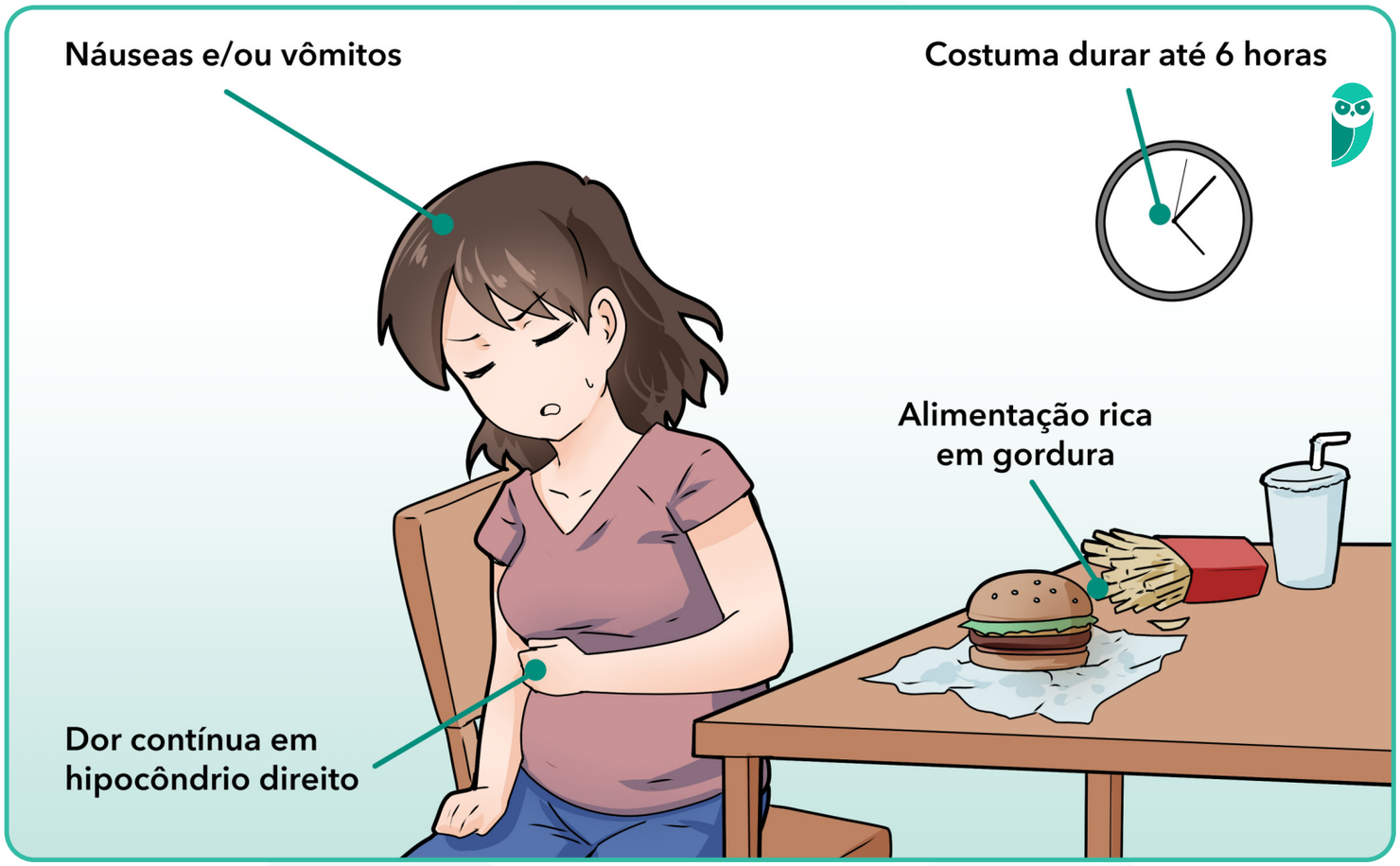


Figura 1 - Cólica Biliar típica

Atenção: se tivermos uma dor em hipocôndrio direito, de forte intensidade, que não melhora ou vem piorando, **FEBRE** e **SINAL DE MURHY**, muito provavelmente estamos diante de uma **COLECISTITE**, e não de uma cólica biliar típica.

Relembrando: sinal de Murphy é a dor à palpação profunda com pausa inspiratória durante a palpação do hipocôndrio direito.

NA PROVA, APARECEU **SINAL DE MURPHY** = PENSAR EM **COLECISTITE AGUDA!**

2.3 COMO FAÇO O DIAGNÓSTICO DE COLELITÍASE?

A ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL É O PRIMEIRO EXAME QUE DEVE SER SOLICITADO NA SUSPEITA DE COLELITÍASE.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.3.1 ULTRASSONOGRAFIA TRANSABDOMINAL

As principais características da colelitíase na ultrassonografia são:

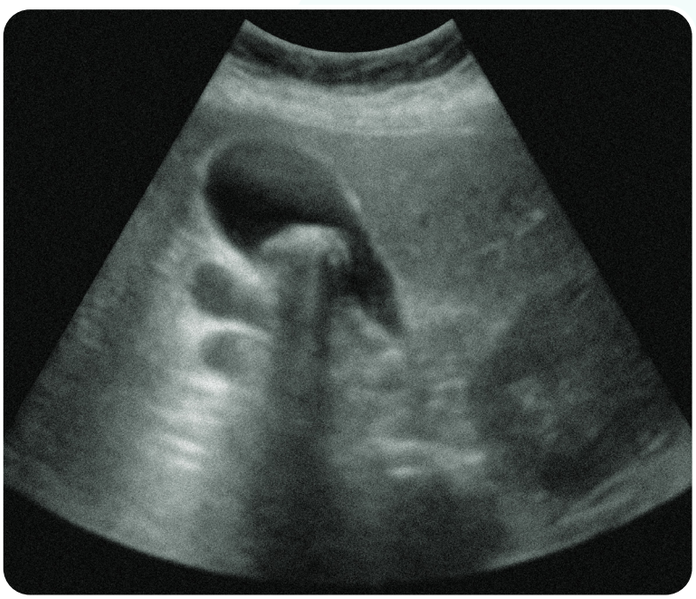


Figura 2 - Ultrassonografia mostrando cálculo em vesícula biliar: densidade elevada e forte sombra acústica posterior (Extraído do concurso de Residência Médica da Faculdade de Medicina de Jundiaí - 2018).

- Os cálculos são acusticamente densos, refletindo as ondas do ultrassom;
- Por não permitirem a passagem das ondas, projetam uma sombra acústica;
- Por não estarem fixas à parede da vesícula, movem-se com a mudança de decúbito;
- Lama biliar, que é uma combinação de muco e microlitíase, é ecogênica, porém não produz sombra acústica.

NÃO SOLICITAR **TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA** NA SUSPEITA DE COLELITÍASE!

2.4 COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA

A regra é clara:

COLELITÍASE SINTOMÁTICA = CIRURGIA

E quando ela é assintomática, em que situações devo indicar a colecistectomia profilática?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INDICAÇÃO DE COLECISTECTOMIA PROFILÁTICA
Pacientes com **ANEMIA FALCIFORME**
Paciente com **VESÍCULA EM PORCELANA**
Cálculo **> 25 mm (2,5 cm**)
MICROCÁLCULOS (pelo risco aumentado de pancreatite biliar)
Pacientes que serão submetidos a **BY-PASS GÁSTRICO OU GASTRECTOMIAS** (Billroth II ou Y de Roux, em que a via biliar fica na alça exclusa)
Paciente que será submetido a **TRANSPLANTE**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
3.0 COLEDOCOLITÍASE

A coledocolitíase é o principal tema cobrado quando falamos de vesícula e via biliar, correspondendo a 27% das questões nos diferentes concursos.

Nesse tema, você tem que ser capaz de identificar, no enunciado, que se trata de uma coledocolitíase... Fique calmo, que lhe direi como fazê-lo.

Indo além, a pergunta, após você reconhecer a coledocolitíase é: **O QUE FAZER?**

E a dúvida é: já devo solicitar CPRE ou não é o momento?

No final desta parte, você será plenamente capaz de responder a essa pergunta.

Vamos em frente!

COLEDOCOLITÍASE: É A PRESENÇA DE CÁLCULO NO INTERIOR DO COLÉDOCO.

Podemos dividir a coledocolitíase em primária ou secundária:

✓ Primária: formada por cálculos marrons, decorre da estase da bile associada à deposição de precipitados de colesterol e produtos bacterianos, principalmente da E. coli. Os cálculos formados em pacientes submetidos à colecistectomia há mais de 2 anos são considerados primários.

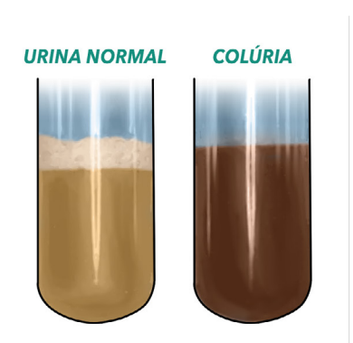
✓ Secundária: secundária à migração de um cálculo da vesícula biliar para o colédoco. Reforçando: se ocorre dentro de 2 (dois) anos após a colecistectomia, é considerada secundária.

3.1 QUANDO SUSPEITAR?

O mais clássico nas provas é o paciente apresentar sintomas colestáticos, secundários à obstrução da bile no colédoco. São eles:



Icterícia



Colúria



Alcolia Fecal

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Aqui vai uma dica valiosa:

O exame inicial na investigação de icterícia obstrutiva é a ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL.
Esta pergunta, "qual é o exame inicial na investigação de icterícia obstrutiva", é muito comum nas provas!!
Cuidado! A banca colocará vários exames desnecessários para confundi-lo!

Quais são as principais características da coledocolitíase na ultrassonografia?

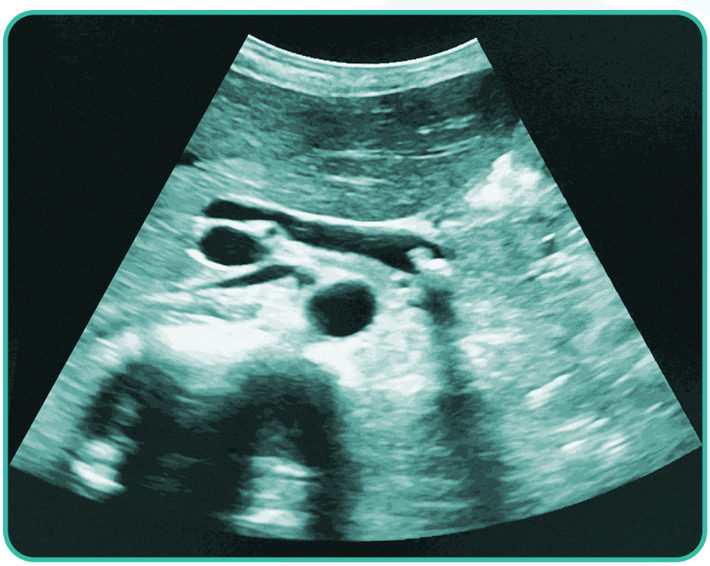


Figura 3 - Coledocolitíase (seta vermelha) observada em ultrassonografia abdominal

✓ Visualização do cálculo:

- Foco ecogênico arredondado;
- A sombra acústica posterior pode estar presente, mas é mais difícil de ser detectada.

✓ Dilatação do colédoco:

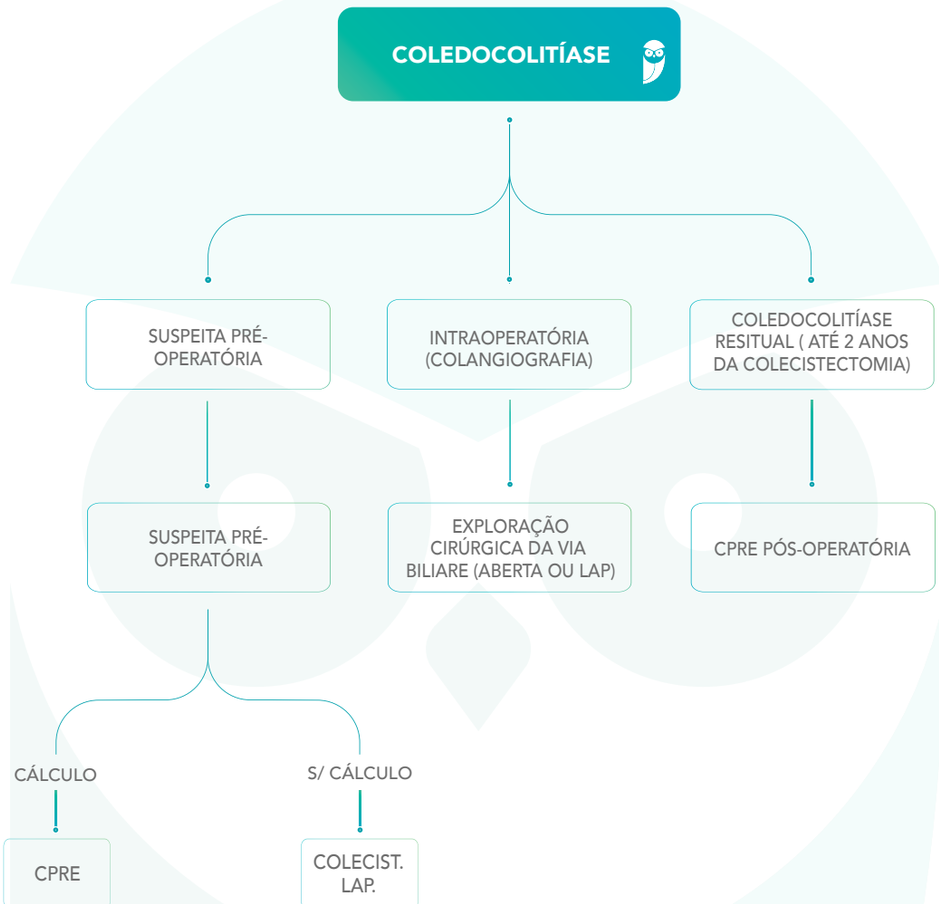
- > 6 mm ou > 8 mm, dependendo da referência (no concurso, fique tranquilo: a banca colocará um tamanho que não gere dúvida!);
- > 10 mm nos pacientes pós-colecistectomia;
- Dilatação da árvore biliar intra-hepática.

3.2 O QUE FAZER APÓS A ULTRASSONOGRAFIA?

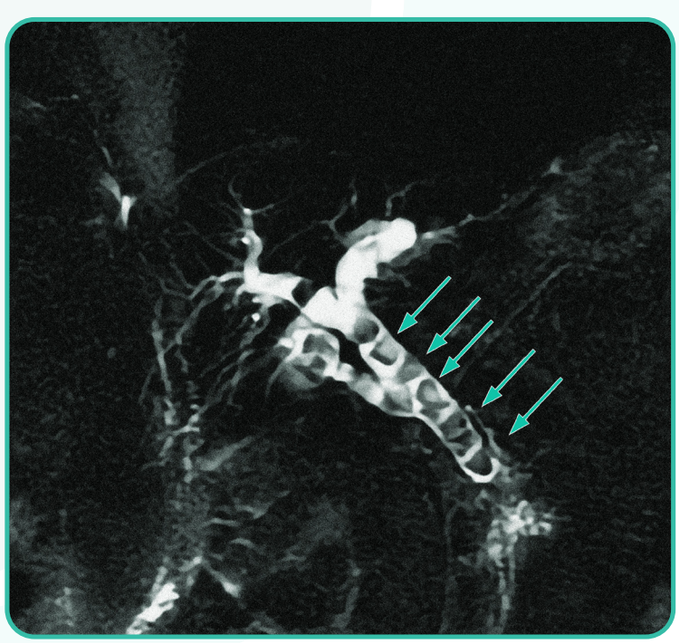
COLEDOCOLITÍASE NA ULTRASSONOGRAFIA = CPRE

"Fiz a ultrassonografia e vi sinais indiretos de coledocolitíase: dilatação da via biliar intra e extra-hepática, porém não identifiquei o fator obstrutivo". Agora, você faz o seguinte:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Na colangiorressonância e na CPRE, a coledocolitíase apresenta-se como uma falha de enchimento do contraste. Olhe um exemplo para você não se esquecer mais:



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

"Prôfe, me ajuda, nunca vi uma colangiografia na vida, o que eu faço?" Então, anote aí para você não errar:

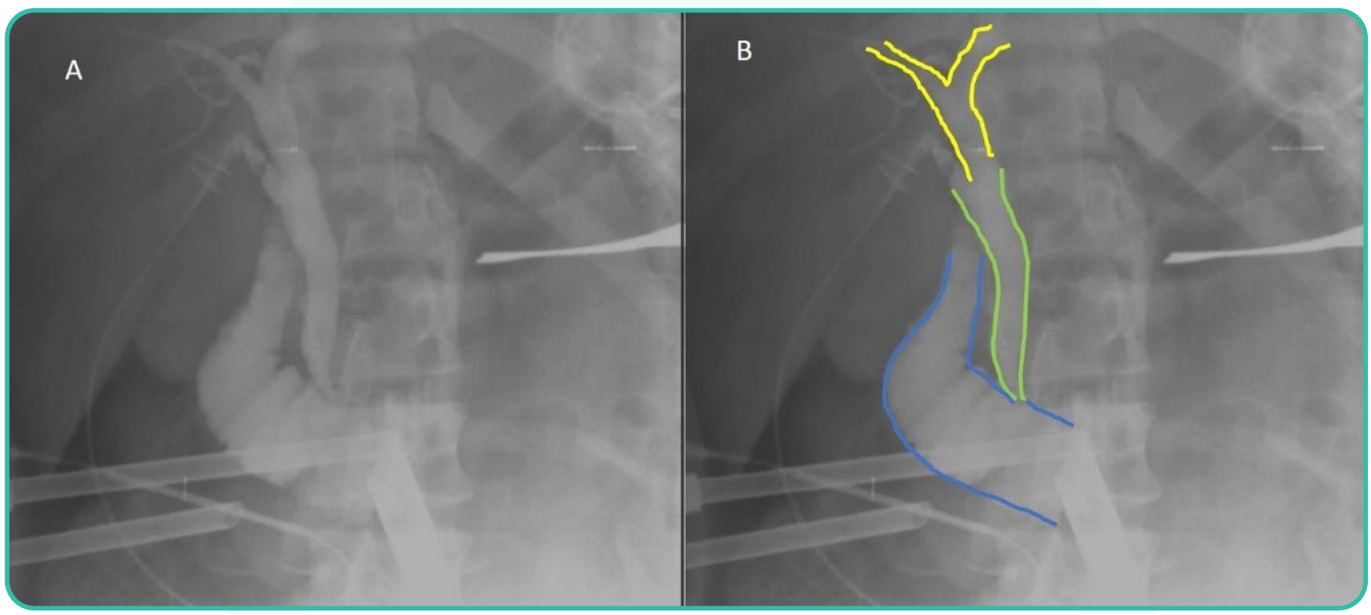


Figura 4 - (A) Colangiografia intraoperatória normal; (B) Marcos anatômicos: amarelo - ductos hepáticos; verde - colédoco; azul - duodeno (Imagem retirada da prova de Residência do HC-USP 2021)

- ☐ Em amarelo, os ductos hepáticos direito e esquerdo;
- ☐ Em verde, o colédoco;
- ☐ Em azul, o duodeno.

Não observou falha de enchimento? Então, a colangiografia é normal.

3.3 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE)

Não poderia sair do tema sem falar do principal exame e tratamento para a coledocolitíase, a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, nossa querida CPRE. A primeira pergunta é: por que não usamos mais a CPRE?

Isso se deve às complicações da CPRE. São elas:

- Risco de pancreatite, que ocorre em até 10% dos casos, sendo em sua maioria casos leves;
- Risco de colangite, pela manipulação da via biliar;
- Risco de perfuração, que ocorre em torno de 0,5-2% dos casos, podendo até ser necessário o tratamento cirúrgico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Como identifico um cálculo na CPRE?

Na CPRE, os cálculos de colédoco são identificados pela FALHA DE ENCHIMENTO da via biliar; além dessa característica, é possível observar a dilatação da via biliar.

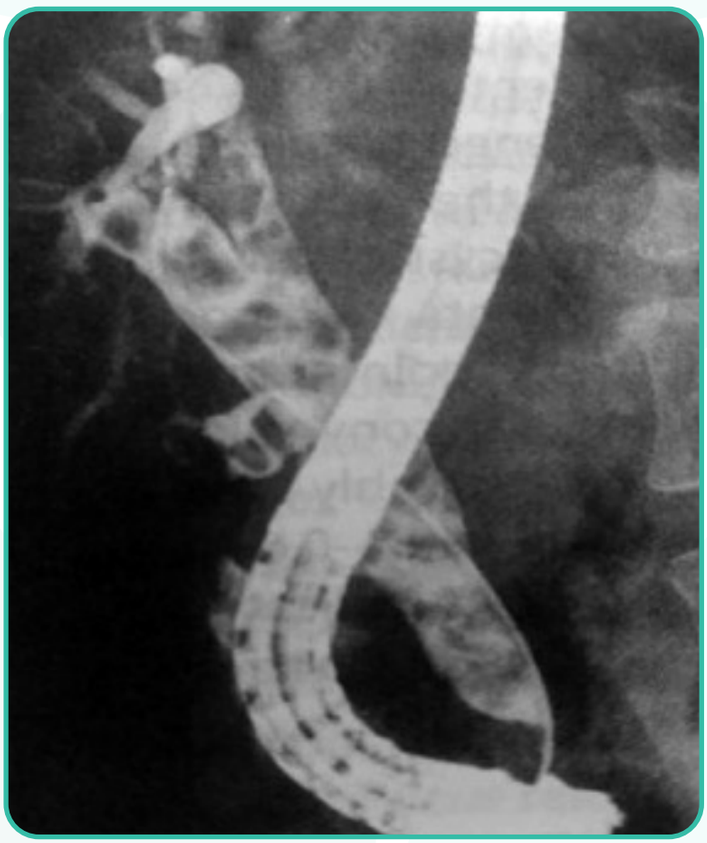


Figura 5 - CPRE evidenciando múltiplos cálculos no colédoco - imagem retirada da prova de residência da UFRJ 2017)

A CPRE trata a coledocolitíase com a extração dos cálculos e realizando uma esfincterotomia/papilotomia, que consiste na abertura das camadas musculares profundas do esfíncter de Oddi, permitindo a livre passagem da bile.

Lembre-se sempre também de que:

Após a CPRE, está indicada a COLECISTECTOMIA pelo risco de recorrência da coledocolitíase.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
4.0 TRATAMENTO CIRÚRGICO

Falaremos sobre a parte cirúrgica da colelitíase e da coledocolitíase, com os principais procedimentos que são cobrados:

- ✓ Colecistectomia,
- ✓ Derivação biliodigestiva.

O tratamento cirúrgico não é um tema muito prevalente nas provas e as perguntas normalmente têm um nível de dificuldade intermediário.

O padrão-ouro para a cirurgia de retirada da vesícula biliar é a **COLECISTECTOMIA LAPAROSCÓPICA**. As vantagens da colecistectomia laparoscópica são:

Um tema que as bancas gostam são as contraindicações para a colecistectomia laparoscópica. São elas:

Contraindicação Absoluta	Contraindicação Relativa
Suspeita de câncer de vesícula	Incapacidade de o paciente tolerar anestesia geral
Instabilidade hemodinâmica	Baixa reserva pulmonar
	Baixa reservar cardíaca
	Doença hepática avançada com hipertensão portal
	Coagulopatia não controlada

4.1 QUANDO DEVO INDICAR UMA DERIVAÇÃO BILIODIGESTIVA?

Quando temos um colédoco muito dilatado, **maior que 15 mm**, esse é considerado disfuncional, permitindo uma estase biliar, ou seja, a bile fica mais tempo do que deveria parada na via biliar. Nesses pacientes, está indicado uma derivação biliodigestiva.

COLÉDOCO > 15 MM = DERIVAÇÃO BILIODIGESTIVA

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A melhor derivação biliodigestiva é a colédoco-jejunostomia em Y-de-Roux. Dê uma olhada na imagem abaixo:

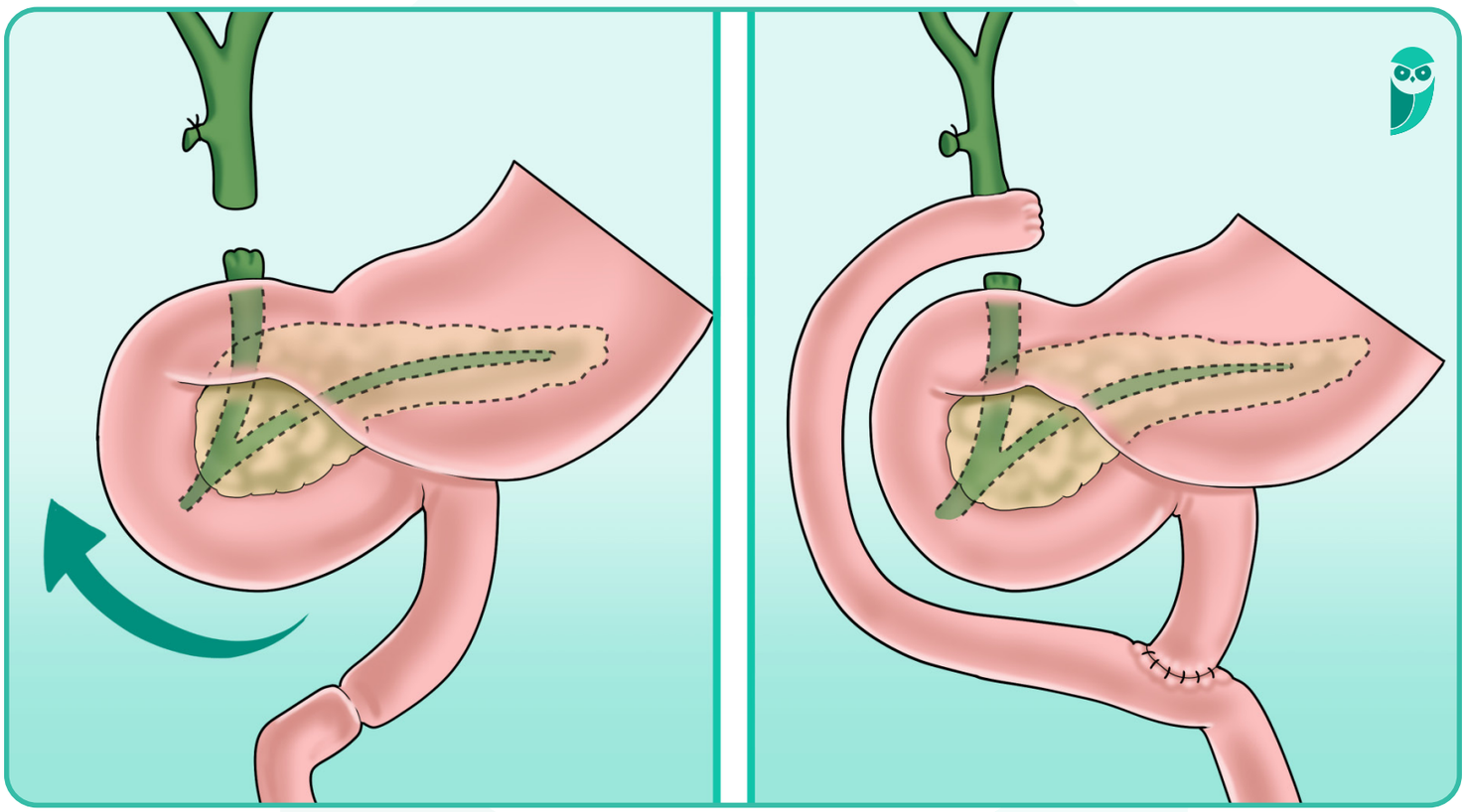


Figura 6 - Anastomose colédoco-jejunal em Y-de-Roux

Outra opção é a anastomose do colédoco com o duodeno término-lateral, porém ela está mais associada ao risco de colangite de repetição, conhecida como *sump syndrome*.

Falaremos agora sobre a complicação mais temida das cirurgias da vesícula: a lesão iatrogênica da via biliar.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
5.0 LESÃO DA VIA BILIAR

Lesão da via biliar é um tema com baixa prevalência nas provas de Residência, em torno de 7%.

- As questões fáceis sobre o assunto pedem para você conseguir diferenciar uma coledocolitíase residual de uma lesão da via biliar;
- Questões com nível intermediário exigem do candidato a escolha do melhor exame para investigação, e iremos mostrar a você que é mais simples do que parece;
- Questões com nível difícil querem que você decida qual é a melhor forma de tratamento. Daremos uma rápida passada sobre as principais opções.

É hora de mais conteúdo!

Uma das piores complicações da colecistectomia é a lesão da via biliar. Ela ocorre por uma série de fatores, mas podemos citar aqui as variações anatômicas, dificuldade técnica e/ou exposição ruim cirúrgica, cirurgia de urgência em vigência de inflamação e até a inexperiência do cirurgião que está iniciando sua jornada.

Nas provas, o principal achado que sugere lesão da via biliar é o surgimento de icterícia no pós-operatório. Quando temos esse sinal clínico, temos duas hipóteses principais:

ICTERÍCIA NO PÓS-OPERATÓRIO DE COLECISTECTOMIA?

1) LESÃO DA VIA BILIAR

2) COLEDOCOLITÍASE RESIDUAL

As lesões da via biliar são classificadas segundo Bismuth e Strasberg. Ela utiliza a localização da lesão e auxilia na tomada de decisão quanto a melhor forma de reconstrução. Dê uma boa olhada nela:

E como eu as diferencio? Veremos uma tabela com as características de cada uma:

COLEDOCOLITÍASE RESIDUAL	LESÃO DA VIA BILIAR
Costuma apresentar sinais e sintomas mais tardiamente	Costuma apresentar sinais e sintomas mais precocemente
Icterícia de padrão flutuante (apresente períodos de icterícia com melhora espontânea)	Icterícia progressiva
Não costuma apresentar sinais de sepse abdominal	Pode apresentar-se com sinais de sepse abdominal quando há coleção biliosa intra-abdominal (coleperitônio)
Pode ser tratada com CPRE	Na maioria dos casos, uma cirurgia derivativa (biliodigestiva) será necessária.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CLASSIFICAÇÃO DA LESÕES IATROGÊNICAS DA VIA BILIAR



Tipo A

Lesão no ducto cístico ou em ductos hepáticos menores que drenam o leito do fígado.



Tipo B

Oclusão de árvore biliar, ducto hepático direito aberrante.



Tipo C

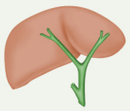
Transecção sem ligação do ducto(s) hepático(s) direito aberrante(s).



Tipo D

Lesão lateral de um ducto biliar maior.

Tipo E (1-5) Lesão no ducto hepático principal; classificados de acordo com o nível de lesão.



E1

E1 (Bismuth tipo 1)
Lesão a mais de 2 cm da confluência.



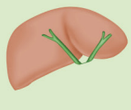
E2

E2 (Bismuth tipo 2)
Lesão a menos de 2 cm da confluência.



E3

E3 (Bismuth tipo 3)
Lesão na confluência; confluência intacta.



E4

E4 (Bismuth tipo 4)
Destruição da confluência biliar.



E5

E5 (Bismuth tipo 5)
Lesão do ducto hepático direito aberrante.

A maioria das bancas pede a classificação do tipo E (a antiga classificação de Bismuth), principalmente dos tipos E1, E2, E3 e E4.
A dica: a confluência dos ductos hepáticos:

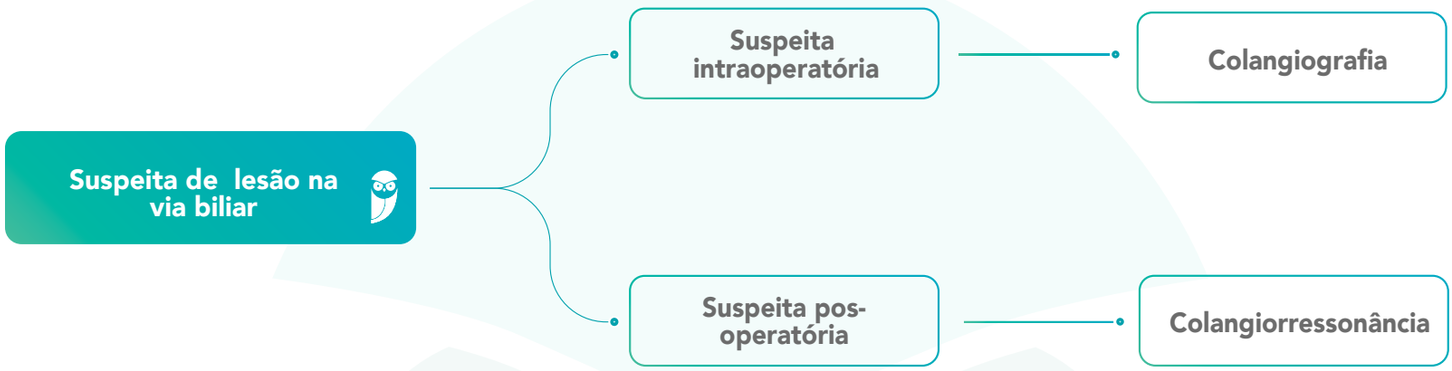
- ✓ > 2 cm – E1;
- ✓ < 2 cm – E2;
- ✓ Junto da confluência – E3;
- ✓ Destruição da confluência – E4.

Decore-a, que lhe será muito útil!!!!

5.1 COMO INVESTIGO UMA LESÃO DA VIA BILIAR?

A resposta para esse questionamento depende do momento em que você suspeita da lesão. Se for no intraoperatório, está indicado uma colangiografia intraoperatória. Se for no pós-operatório, a melhor indicação é a realização de uma colangiorressonância. Então, Estrategista, anote aí:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



E como eu trato? Muita atenção, porque há alguns detalhes bem específicos.

Caso seja identificada lesão no **INTRAOPERATÓRIO**, está indicada reconstrução imediata. Dê uma olhada na tabela abaixo com os conceitos principais para a tomada de decisão:

IDENTIFICAÇÃO DA LESÃO DA VIA BILIAR NO INTRAOPERATÓRIO	
Se lesão < 50% da circunferência **E** não causada por eletrocautério	Rafia da via biliar + dreno de Kehr
Lesões térmicas	Derivação biliodigestiva
Lesão > 50%	Derivação biliodigestiva

Na suspeita de lesão da via biliar no **PÓS-OPERATÓRIO**, muito cuidados nas questões. Se o paciente se apresentar com sinais de **sepse abdominal** (dor, febre, descompressão brusca), a primeira medida é a **reabordagem cirúrgica**, porque nesse caso temos uma coleção que não está drenada!

Dando seguimento a nosso raciocínio cirúrgico, faremos o exame de imagem para avaliação da anatomia da via biliar e indicaremos uma derivação biliodigestiva para reestabelecer a continuidade da via biliar. A opção de derivação biliodigestiva depende do tipo da lesão e do local do acometimento.

Até aqui, vimos os principais temas que são cobrados nas provas de Residência Médica e REVALIDA. Juntando colelitíase, coledocolitíase, tratamento cirúrgico e lesão da via biliar, somam quase de 70% das questões em concursos.
Por isso, considero-as o principal foco dos seus estudos.
Em nosso banco de questões, sugiro selecionar esses temas para aprofundar a revisão e sedimentar o conhecimento, parte importante do nosso estudo estratégico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
6.0 PÓLIPOS DE VESÍCULA BILIAR

Os pólipos de vesícula biliar são uma patologia rara, mas algumas bancas adoram cobrá-la na prova. A principal pergunta sobre os pólipos é:

Quando indicar a colecistectomia frente a um pólipo de vesícula biliar?

As perguntas sobre pólipos representam algo em torno de 4,5% das questões sobre vesícula e vias biliares.

Por isso, muita atenção às indicações de colecistectomia no pólipo e suas principais características.

Os pólipos de vesícula biliar são crescimentos (protuberâncias) da mucosa da vesícula biliar. Veremos uma tabela comparativa dos principais tipos de pólipos da vesícula biliar:

PÓLIPO DE COLESTEROL	ADENOMIOMATOSE	PÓLIPO ADENOMATOSO
São os mais comuns	Raro	Potencial Maligno
Consequência do acúmulo de lipídios na mucosa da vesícula	Espessamento da camada muscular, apresenta divertículos intramurais	Tumores epiteliais benignos com células semelhantes ao epitélio biliar
Tamanho < 1 cm	Tamanho > 1 cm	Tamanho variável
Múltiplos	Único	Único
Maioria pediculados	Aspecto séssil	Risco de neoplasia aumenta com o tamanho do pólipo
Aspecto ecogênico na USG, não apresentam sombra acústica posterior	Aspecto séssil, localizada no fundo da vesícula, associado a microcistos	Difícil diferenciação com o adenocarcinoma de vesícula biliar

A maioria dos pólipos é um achado de exame e é assintomática. E aí, o que devemos fazer frente a esse achado?

As bancas gostam de cobrar a indicação de colecistectomia quando encontramos um pólipo de vesícula biliar. A próxima tabela é a parte mais importante desse tema.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

INDICAÇÃO DE COLECISTECTOMIA NO PÓLIPO DE VESÍCULA BILIAR
Pacientes com pólipo de vesícula biliar **associado a litíase biliar**
Pacientes com **adenomiomatose** de vesicula biliar associada.
Pacientes **sintomáticos** (cólica biliar e/ ou pancreatite aguda)
Pólipos **maiores que 10** mm em paciente assintomático
Pólipo **em crescimento (aumento > 2 mm)**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
7.0 CÂNCER DE VESÍCULA

Falaremos rapidamente, no início, sobre a epidemiologia do câncer de vesícula, para você ter uma ideia inicial sobre o tema.
É um assunto que não cai muito (7,5%), e a maioria das perguntas quer saber do candidato:
- O que fazer após o achado incidental de câncer de vesícula pós-colecistectomia?
Sabendo isso, você acertará a maioria das questões sobre o tema!

O câncer de vesícula biliar é uma neoplasia rara, com baixa incidência. No entanto, em contrapartida, apresenta um prognóstico ruim. Isso se deve ao diagnóstico tardio na maioria dos casos, em que a doença já está localmente avançada ou metastática.

Por que isso ocorre? Bem, os sintomas são bem vagos e pouco específicos. Uma explicação está no fato de que a maioria dos tumores se desenvolve no fundo da vesícula biliar.

Qual é o grupo que tem "melhor prognóstico"? Os que apresentam sintomas semelhantes aos de colelitíase ou colecistite.

Ele acomete mais a população idosa (6ª-7ª décadas de vida), 2x-3x mais o sexo feminino que o masculino e tem como principal fator de risco a colelitíase, principalmente os macrocálculo (> 25mm). Outros fatores de risco são os cistos biliares, a vesícula em porcelana, a colangite esclerosante primária, os pólipos de vesícula biliar e a infecção crônica por *Salmonella typhi*.

O tipo histológico mais comum é o **ADENOCARCINOMA**, dividido nos subtipos papilar, nodular e tubular. O subtipo papilar é o que apresenta melhor prognóstico, porém corresponde a menos de 10% das neoplasias da vesícula biliar.

Como disse a você, o principal fator de risco é, sem sombra de dúvida, a colelitíase. Então, alguns pacientes operam por colelitíase e são surpreendidos com o achado incidental de câncer de vesícula.

1% a 2% dos cânceres de vesícula são identificados após uma colecistectomia.

Esse é o tema PREFERIDO das bancas: QUAL É A CONDUTA FRENTE AO ACHADO DE CÂNCER DE VESÍCULA INCIDENTAL?

Para isso, deve-se decorar o estadiamento T para o câncer de vesícula. Deixarei só o que nos interessa: T1a, T1b, T2 e T3. Um tumor T4, que é um tumor localmente avançado, dificilmente não é diagnosticado no pré-operatório.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESTADIAMENTO TNM DO CÂNCER DE VESÍCULA (AJCC 8ª EDIÇÃO)		
TUMOR PRIMÁRIO (T)		**CONDUTA CIRÚRGICA**
T1a	Tumor invade a lâmina própria	Colecistectomia simples; o risco de margens positivas ou linfonodos positivos é muito baixa, não sendo necessário complementar o tratamento.
T1b	Tumor invade a camada muscular	Ampliação das margens, com ressecção do leito hepático, associada à linfadenectomia
T2	Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado peritoneal, sem envolvimento do peritônio visceral OU Tumor invade o tecido conjuntivo perimuscular no lado hepático, sem extensão para o fígado	Hepatectomia dos segmentos IVb e V, associada à linfadenectomia
T3	Tumor perfura a serosa (peritônio visceral) e/ou invasão direta hepática e/ou invasão de 1 órgão ou estrutura adjacente, como estômago, duodeno, cólon, pâncreas, omento ou via biliar extra-hepática.	Hepatectomia dos segmentos IVb e V, associada à linfadenectomia, nos casos em que há somente a perfuração da serosa. A ressecção em monobloco com outros órgãos deve ser restrita a grandes centros.

Uma dúvida que pode passar pela sua cabeça: eu tenho que ressecar a via biliar (colédoco)? Olhe a dica: depende da margem do ducto cístico.

Caso a margem do ducto cístico seja positiva para neoplasia, está indicada ressecção da via biliar e reconstrução com hepaticojejunostomia em Y-de-Roux.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
8.0 COLANGIOCARCINOMA

Ufa, chegamos no último item do nosso RESUMO ESTRATÉGICO. No entanto, não se engane: colangiocarcinoma é um tema traiçoeiro!

Apesar de ser uma neoplasia rara, tem uma incidência de 10% nas provas de Residência. E o que o examinador quer de você? Basicamente:

- ✓ Que saiba que os tumores peri-hilares são conhecidos como TUMORES DE KLATSKIN (acredite, tem muita pergunta que é só isso!);
- ✓ Que saiba classificar os tumores peri-hilares pela classificação de Bismuth;
- ✓ Que saiba indicar a melhor cirurgia e que saiba as principais contraindicações.

Não desanime... Simbora!

O colangiocarcinoma é uma neoplasia que surge no epitélio dos ductos biliares. Ele pode surgir em qualquer parte da via biliar. O local mais comum é no ducto hepático, chamado de tumor peri-hilar. Esses tumores também são conhecidos como TUMORES DE KLATSKIN!

Além deles, temos os colangiocarcinomas nos ductos dentro do fígado (intra-hepático) e no colédoco distal.

Os colangiocarcinomas diferem do câncer de vesícula pois são mais comuns no sexo masculino que no feminino e a maioria dos pacientes têm entre 50-70 anos.

O principal fator implicado para o surgimento do colangiocarcinoma é a inflamação crônica e repetida da via biliar. Podemos citar como principais fatores de risco:

- Colangite esclerosante primária;
- Cistos da via biliar;
- Colangite piogênica recorrente.

O colangiocarcinoma é um tumor raro, com prognóstico bem reservado: a maioria dos pacientes tem tumor irressecável no momento do diagnóstico. Grande parte dos tumores são **ADENOCARCINOMAS**.

Nos colangiocarcinomas peri-hilares e distais, o principal sinal é a presença de icterícia de padrão obstrutivo. Aqui, atenção a um detalhe importante: como a obstrução nos tumores peri-hilares está ACIMA do ducto cístico, a vesícula encontra-se murcha! Nos tumores intra-hepáticos, é comum a ausência da icterícia, o que torna ainda mais difícil seu diagnóstico precoce.

Diferentemente do câncer de vesícula, no colangiocarcinoma temos a presença do marcador tumoral CA 19-9. É sempre bom lembrar que ele tem valor prognóstico e no seguimento, porém não tem finalidade diagnóstica.

Na suspeita de colangiocarcinoma, o exame mais indicado para avaliação da via biliar é a COLANGIORRESSONÂNCIA. A CPRE ficará reservada para os casos em que precisarmos drenar a via biliar.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O que as bancas mais amam sobre os colangiocarcinomas é a classificação de Bismuth-Corlette para os tumores de Klatskin.

A classificação de Bismuth-Corlette é utilizada nos tumores de Klatskin e é útil para determinamos qual é a cirurgia mais indicada para cada caso. Vamos dar uma olhada?

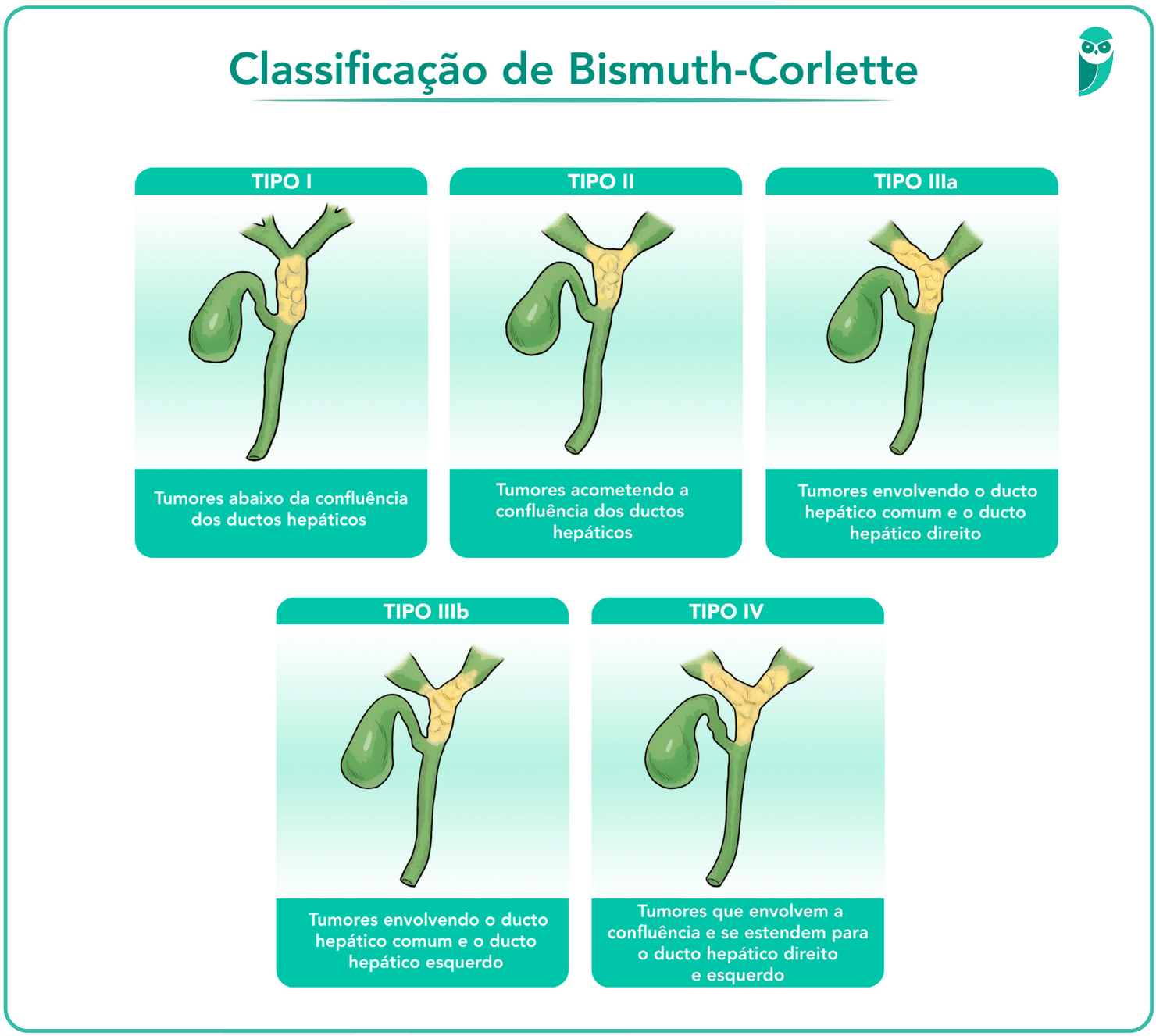


Figura 9 - Classificação de Bismuth-Corlette.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

TRATAMENTO CIRÚRGICO CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DE BISMUTH-CORLETTE DO COLANGIOCARCINOMA	
TIPO	**DESCRIÇÃO**
TIPO I	Ressecção da via biliar extra-hepática e reconstrução com hepaticojejunostomia em Y-de-Roux associada à linfadenectomia.
TIPO II	Ressecção da via biliar extra-hepática associada à ressecção do lobo caudado e reconstrução com hepaticojejunostomia em Y-de-Roux associada à linfadenectomia.
TIPO III A	Ressecção da via biliar extra-hepática + trissetorectomia direita (IV, V,VI, VII e VIII) + ressecção do lobo caudado e anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático esquerdo em Y-de-Roux associada à linfadenectomia locorregional.
TIPO III B	Ressecção da via biliar extra-hepática + hepatectomia esquerda (II. III. IV) + ressecção do lobo caudado e anastomose hepaticojejunal com o ducto hepático direito em Y-de-Roux associada à linfadenectomia locorregional.
TIPO IV	Esse tipo de tumor é frequentemente irressecável. Os casos potencialmente ressecáveis devem ser encaminhados a centros.

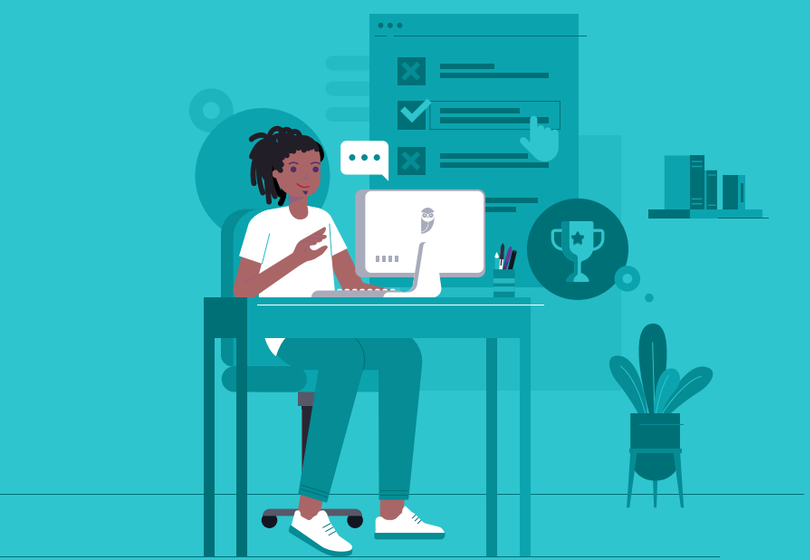
Para os colangiocarcinomas intra-hepáticos, a lobectomia do lado acometido (direita ou esquerda) é recomendada;
Para os tumores do colédoco distal, a duodenopancreatectomia (cirurgia de Whipple) é o tratamento indicado.

Este é o momento de fazer uma pausa, relaxar um pouco e partir para resolução das questões comentadas!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://bit.ly/37CnRj4

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

10.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Townsend, C. M. et al. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders, 2017.
2. BRUNICARDI, F. C. et al. Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education, 2014.
3. STANDRING, Susan; BORLEY, Neil R.; GRAY, Henry. Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. [Edinburgh]: Churchill Livingstone/Elsevier, 2008.
4. BUXBAUM, J.L. et al. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasis. Gastrointestinal endoscopy. 2019;89(6):1075-105.e15.
5. STRASBERG S.M.; BRUNT, L.M. Rationale and use of the critical view of safety in laparoscopic cholecystectomy. Journal of the American College of Surgeons. 2010;211(1):132-8.
6. RIZVI, S. et al. Cholangiocarcinoma - evolving concepts and therapeutic strategies. Nat Rev Clin Oncol. 2018 Feb;15(2):95-111. doi: 10.1038/nrclinonc.2017.157. Epub 2017 Oct 10. PMID: 28994423; PMCID: PMC5819599.
7. SHARMA, A. et al. Gallbladder cancer epidemiology, pathogenesis, and molecular genetics: Recent update. World J Gastroenterol. 2017 Jun 14;23(22):3978-3998. doi: 10.3748/wjg.v23.i22.3978. PMID: 28652652; PMCID: PMC5473118.
8. JONES, M. W.; FERGUSON, T. Mirizzi Syndrome. 2020 Oct 1. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 29494098.
9. LEVY, A. D.; ROHRMANN Jr, C. A. Biliary cystic disease. Curr Probl Diagn Radiol. 2003 Nov-Dec;32(6):233-63. doi: 10.1016/j.cpradiol.2003.08.002. PMID: 14647122.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
11.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fale, Estrategista!

Chegamos ao fim deste **RESUMO ESTRATÉGICO** de **VESÍCULA E VIAS BILIARES**.

Com este resumo, cobrimos todos os principais temas que são cobrados nas provas em que o assunto é abordado.

Este resumo, por sua finalidade, não substitui o livro digital, em que o conteúdo é bem maior; no entanto, acredito que ele irá ajudá-lo como forma de revisão e direcionamento do estudo.

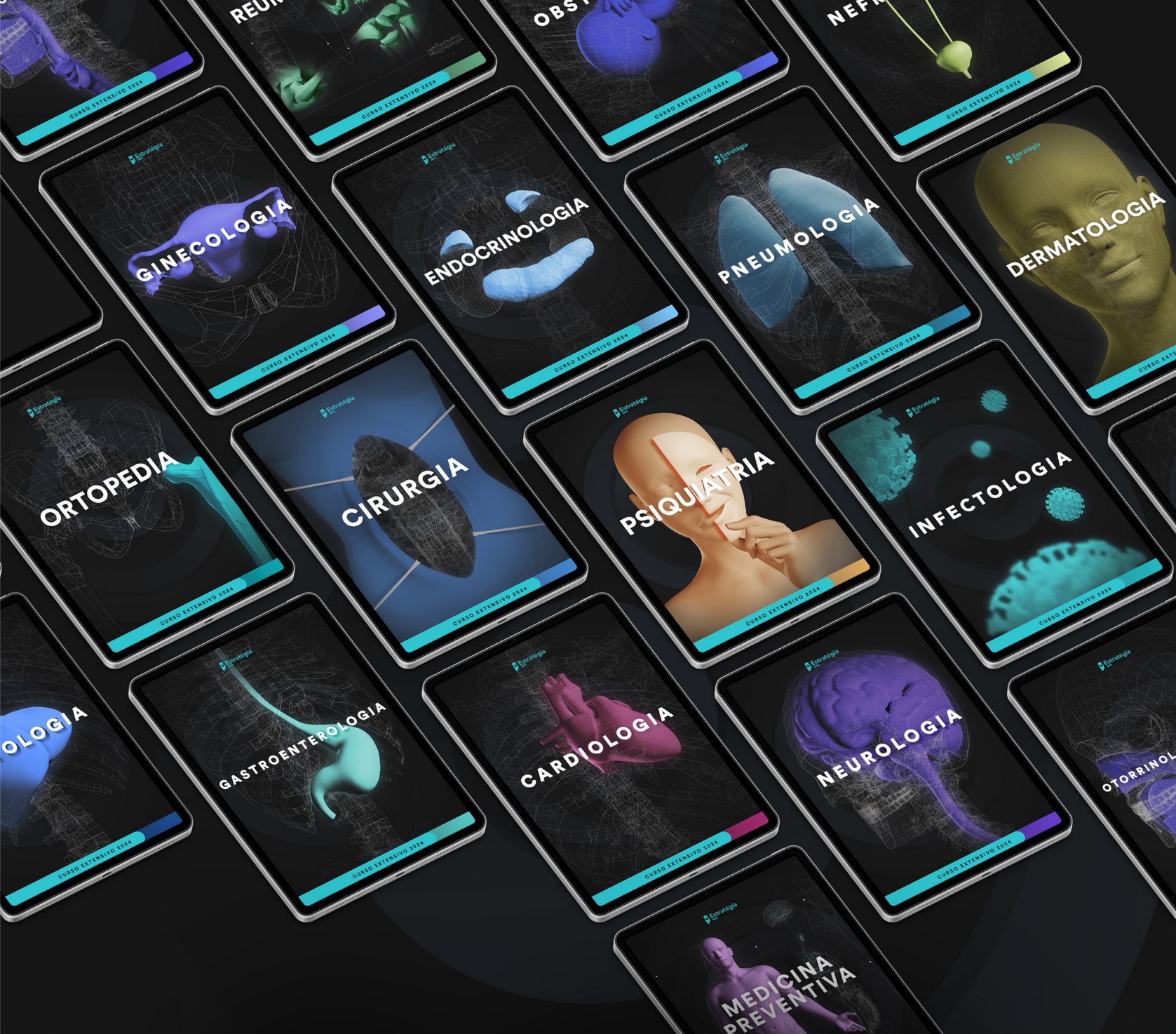
Foi um prazer passar esse tempo com você...

Para quaisquer dúvidas, os canais estão abertos!

Instagram: @proftomascoelho

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE ABRAÇO & UM FORTE BEIJO!!

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina